



Nuansa
Fajar
Cemerlang

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENGURANGI KECEMASAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III MENGHADAPI PERSALINAN

Idah Ayu Wulandari
Ni Wayan Manik Parwati

Dukungan Keluarga dalam Mengurangi Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III Menghadapi Persalinan

Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb.

Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Dukungan Keluarga dalam Mengurangi Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III Menghadapi Persalinan

Penulis: Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb.
Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-03-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga buku "**Dukungan Keluarga dalam Mengurangi Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III Menghadapi Persalinan**" dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan mental ibu hamil, khususnya pada trimester ketiga, periode yang seringkali diiringi kecemasan tinggi menjelang persalinan.

Trimester ketiga kehamilan menandai fase akhir kehamilan yang penuh antisipasi dan sekaligus kecemasan. Perubahan fisik yang signifikan, persiapan persalinan, dan kekhawatiran akan proses persalinan itu sendiri dapat memicu kecemasan yang berlebihan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam mengurangi kecemasan tersebut. Di dalamnya, dibahas berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan keluarga, mulai dari dukungan fisiologis hingga emosional, serta strategi praktis untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan dan suportif bagi ibu hamil.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, termasuk para ahli, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan siapa pun yang peduli terhadap kesejahteraan ibu hamil. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh

karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang

Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan mental ibu hamil dan mempersiapkan mereka menghadapi persalinan dengan lebih tenang dan percaya diri.

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v

Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Dukungan Keluarga.....	4
A. Pengertian	4
B. Struktur Keluarga	8
C. Tipe Keluarga.....	11
D. Fungsi Keluarga.....	15
E. Fungsi Dukungan Keluarga.....	20
F. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga	24
G. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan	28
H. Manfaat Dukungan Keluarga	31
Bab 3 Kecemasan.....	32
A. Definisi Kecemasan	32
B. Tanda dan Gejala Kecemasan	33
C. Faktor – Faktor Penyebab Kecemasan.....	35
D. Dampak Kecemasan	37
E. Tingkatan Kecemasan	39
Bab 4 Kehamilan.....	44
A. Pengertian Kehamilan	44
B. Trimester dalam Kehamilan	44
C. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan Trimester III	46
D. Perubahan Psikologis pada Kehamilan Trimester III	48
E. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Trimester III.....	50

Bab 5 Dampak Dukungan Keluarga Terhadap	
Kecemasan Ibu Hamil	56
Bab 6 Penutup	61
Daftar Pustaka	63
Glosarium	67
Profil Penulis	69

Bab 1

Pendahuluan

Persalinan adalah proses alami yang akan dirasakan oleh tiap perempuan, serta tidak dapat dipungkiri jika proses menjadi seorang ibu merupakan proses yang sangat menantang serta penuh tantangan. Trimester ketiga kehamilan meningkatkan stres pada ibu dan keluarga karena persiapan persalinan, baik fisik maupun mental. Kecemasan dan kekhawatiran seputar persalinan dapat menyebabkan stres yang berlebihan, sama bahayanya dengan kebiasaan merokok bagi ibu hamil. Stres selama kehamilan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kepala besar (macrosomia), atau prematur, dibandingkan kehamilan yang dijalani dengan tenang dan Bahagia (Wang et al., 2024).

Kecemasan adalah rasa khawatir, rasa takut yang tidak jelas sebabnya. Berdasarkan data ADAA (Anxiety and Depression Association of Amerika) menyebutkan bahwa 52% dari wanita hamil melaporkan peningkatan kecemasan atau depresi saat hamil (Alves et al., 2021). Rasa cemas dan khawatir pada ibu hamil akan meningkat seiring dengan mendekatinya waktu persalinan (Rafiei et al., 2019). Kecemasan dalam kehamilan merupakan masalah yang serius karena dapat memengaruhi kesehatan mental ibu hamil dan berdampak negatif pada hasil kehamilan. Bahkan wanita hamil yang sehat tanpa riwayat depresi atau kecemasan pun berpotensi

mengalami kecemasan kehamilan. Masalah stress dan kecemasan senantiasa muncul pada ibu hamil khususnya primigravida oleh karena itu masalah kecemasan tersebut harus diatasi. Berdasarkan penelitian didapati hasil bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan, meningkatkan level kortisol yang dapat berhubungan dengan rendahnya berat janin (Basharpoor et al., 2017). Efek buruk kecemasan kehamilan pada kesehatan anak sangat luas dan dapat dibagi menjadi empat kelompok: biologis, mental, perilaku, dan medis. Kecemasan ibu hamil yang tinggi juga meningkatkan risiko persalinan prematur dan ketakutan persalinan, serta preferensi untuk operasi Caesar (Madhavanprabhakaran et al., 2015).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kecemasan, depresi, dan stres selama kehamilan dapat berdampak buruk bagi ibu dan bayi. Kecemasan menyebabkan terjadinya kelahiran premature, BBLR, berpotensi menyebabkan masalah pada perkembangan otak janin dan kesehatan anak setelah lahir, BBLR (Schetter et al., 2015).

Kecemasan berlebihan dapat mempersulit persalinan karena kondisi psikologis ibu sangat mempengaruhi proses tersebut. Gangguan psikologis kecemasan selama kehamilan berhubungan dengan terjadinya indeks resistensi pada arteri uterin. Hal ini dikarenakan oleh terjadinya peningkatan konsentrasi noradrenalin dalam plasma darah, sehingga aliran darah ke uterus terganggu. Uterus sangat sensitif terhadap noradrenalin dan dapat menimbulkan efek vasokonstriksi. Mekanisme ini mengakibatkan terhambatnya proses pertumbuhan serta perkembangan janin intra uterin karena berkurangnya oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kejadian berat badan lahir rendah/BBLR (Alves et al., 2021). Selain itu, kondisi stress dan cemas dapat merangsang

peningkatan hormon kortikotropin yang diketahui berinteraksi dengan hormon oksitoksin dan prostaglandin. Hormon oksitoksin memediasi kontraksi uterus sehingga terjadi kelahiran sebelum waktunya (Bedaso et al., 2021)

Komplikasi kelahiran dan kematian ibu dapat dihindari dengan memberikan perawatan, perlindungan dan pertolongan yang baik secara bersama-sama dan terpadu antara keluarga khususnya keluarga, masyarakat dan pemerintah. Melihat kenyataan di masyarakat dukungan keluarga sangat membantu seorang ibu untuk menjalani kehidupan baru sebagai wanita hamil terutama trimester III yang akan mengalami berbagai perubahan fisik maupun emosi (Yu et al., 2020). Dukungan aktif keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kepedulian ibu atas kesehatan diri dan janinnya. Ibu hamil terutama trimester III yang mendapatkan dukungan dari keluarga dapat mencegah timbulnya kecemasan sehingga ibu merasa lebih percaya diri, bahagia dan siap dalam menjalani kehamilan, persalinan dan masa nifas. Buku ini membahas tuntas tentang dukungan keluarga dan kecemasan yang terjadi pada ibu hamil, khususnya pada trimester III dan dampak dukungan keluarga terhadap penurunan tingkat kecemasan ibu hamil (Berg et al., 2021)

Bab 2

Dukungan Keluarga

A. Pengertian

Keluarga adalah seperti taman yang penuh kasih sayang, di mana individu tumbuh dan berkembang menjadi diri mereka sendiri. Di sini, mereka mendapatkan nutrisi penting untuk hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi, lebih dari itu, keluarga juga memberikan nutrisi emosional dan mental yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Bayangkan seorang anak kecil seperti pohon kecil yang baru tumbuh. Ia membutuhkan tanah yang subur, air yang bersih, dan sinar matahari untuk tumbuh kuat. Begitu pula dengan anak, mereka membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan dari orang tua untuk tumbuh sehat dan bahagia. Melalui interaksi dan komunikasi dengan anggota keluarga, anak belajar tentang nilai-nilai penting dalam hidup. Mereka melihat bagaimana orang tua mereka memperlakukan satu sama lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka menghadapi berbagai situasi dalam hidup (Setiono, 2011).

Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang, ditanamkan secara perlahan melalui contoh dan ajaran orang tua. Seperti pohon yang tumbuh dengan kuat karena akarnya yang kokoh, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang akan memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka belajar untuk menghargai diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Tentu saja, setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangannya sendiri. Namun, melalui komunikasi terbuka, saling pengertian, dan dukungan, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. keluarga adalah pondasi yang kuat untuk membangun kepribadian yang utuh dan bermakna (Retnaningsih, 2021)

Keluarga merupakan unit sosial terpenting yang menghubungkan individu dengan kelompok yang lebih besar. Sebagai kelompok sosial pertama yang dijalani anak-anak, keluarga berperan krusial dalam proses sosialisasi awal mereka. Keluarga terdiri dari dua individu atau lebih yang terikat oleh darah, pernikahan, atau adopsi, tinggal bersama, berinteraksi, dan secara bersama-sama menciptakan serta melestarikan budaya mereka. Hubungan darah berarti Ikatan yang paling dasar terbentuk melalui kelahiran. Orang tua, anak, dan saudara kandung memiliki hubungan darah yang kuat, membawa warisan genetik dan sejarah keluarga. Hubungan perkawinan berarti pernikahan menciptakan ikatan baru, menghubungkan dua individu dari keluarga yang berbeda. Mereka membentuk keluarga baru, mungkin dengan anak-anak mereka sendiri, dan membangun tradisi Bersama. Pengangkatan adalah adopsi menciptakan ikatan keluarga melalui legalitas, memberikan kasih sayang dan

dukungan kepada anak yang membutuhkan keluarga. Hidup dalam satu rumah tangga berarti keluarga berbagi tempat tinggal, menciptakan ruang bersama untuk makan, tidur, dan berinteraksi. Rumah tangga menjadi simbol kesatuan dan tempat untuk membangun kenangan Bersama (Friedman, 2010). Interaksi dan peran yang dimaksud adalah anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, membangun hubungan dan peran mereka dalam keluarga. Orang tua membimbing, anak-anak belajar, saudara kandung saling mendukung, sedangkan menciptakan dan mempertahankan budaya artinya keluarga menjadi wadah untuk meneruskan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan turun-temurun. Cara memasak, bahasa, keyakinan, dan kebiasaan keluarga menjadi bagian dari budaya yang unik dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Sampeangin & Niman, 2022).

Keluarga bukan hanya sekumpulan individu yang tinggal bersama. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang saling terhubung, saling mendukung, dan menciptakan ikatan yang kuat. Mereka membangun budaya keluarga, memberikan rasa identitas dan kebersamaan, dan membentuk individu-individu yang siap menghadapi dunia.

Menurut Duvall, Keluarga adalah kelompok individu yang terikat oleh pernikahan, adopsi, atau kelahiran, yang bersama-sama menciptakan dan menjaga nilai-nilai bersama, serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya. Sebagai unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat, keluarga berperan vital dalam kesejahteraan anggota-anggotanya, di mana asuhan, kesehatan, dan kualitas hidup saling berkaitan. Keluarga jelas berperan sebagai penghubung antara individu dan masyarakat luas (Setiono, 2011)

Menurut Friedman keluarga menunjukkan dukungan mereka kepada anggota keluarga melalui tindakan dan sikap berupa pemberian informasi, nasihat, bantuan praktis, dan penguatan emosional. Dukungan keluarga adalah seperti pelukan hangat yang diberikan oleh orang-orang terdekat kita saat kita membutuhkannya. Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan keinginan untuk membantu anggota keluarga dalam berbagai situasi. Dukungan keluarga hadir dalam berbagai bentuk Dukungan keluarga juga didefinisikan sebagai dorongan berupa bantuan, perhatian penghargaan, atau kepedulian yang didapatkan dari suatu ikatan individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah. Dukungan sosial merupakan suatu bentuk kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang didapatkan individu dari individu lain dan kelompok (Friedman, 2010)

Dukungan keluarga adalah kepedulian, kesedihan yang sama perasaan ikut serta menanggung beban yang sama dari orang-orang yang menghargai menyayangi, dapat diandalkan, baik terikat hubungan darah maupun hubungan sosial. Dukungan keluarga merupakan bentuk dukungan interpersonal yang meliputi sikap, perilaku, dan penerimaan keluarga. Keluarga adalah sebuah sistem yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan semua anggota yang tinggal bersama. Mereka saling bergantung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai sistem terbuka, keluarga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Memahami keluarga sebagai sebuah sistem membantu kita untuk lebih memahami dinamika keluarga, interaksi anggota keluarga, dan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan keluarga. Semua anggota keluarga ini saling berinteraksi, berkomunikasi, dan memengaruhi satu sama lain. Mereka

saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan Bersama. Secara umum, karakteristik keluarga terdiri atas dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dimana anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial sebagai suami, istri, anak, kakak, dan adik yang mempunyai tujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota (Potter & Perry, 2010)

B. Struktur Keluarga

Struktur keluarga merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana anggota keluarga saling berhubungan dan berperan dalam kehidupan bersama. Berikut adalah beberapa elemen penting yang membentuk struktur keluarga (Pierce et al., 1996):

1. Hubungan antar anggota:

a. Orang tua-anak

Hubungan ini menjadi fondasi utama keluarga, melibatkan tanggung jawab, kasih sayang, dan bimbingan orang tua terhadap anak-anak.

b. Pasangan

Hubungan antara suami dan istri atau pasangan sejenis, yang dibentuk atas dasar cinta, komitmen, dan kesepakatan bersama.

c. Saudara

Hubungan antara anak-anak dalam keluarga, yang bisa melibatkan persahabatan, persaingan, dan saling mendukung.

- d. Keluarga Luas
Hubungan dengan anggota keluarga yang lebih luas seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan sepupu, yang bisa menghadirkan dukungan, tradisi, dan nilai-nilai budaya.
2. Peran dan Tanggung Jawab:
- a. Peran Orang Tua
Memberikan asuhan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi anak-anak.
 - b. Peran Anak
Menghargai dan menghormati orang tua, belajar dan berkembang, serta berkontribusi dalam keluarga.
 - c. Peran Pasangan
Saling mencintai, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun keluarga.
 - d. Peran Anggota Keluarga Luas
Memberikan nasihat, dukungan, dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.
3. Pola Pengasuhan:
- a. Pola Otoriter
Orang tua memegang kendali penuh, menuntut kepatuhan, dan memberikan hukuman jika aturan dilanggar.
 - b. Pola Permisif
Orang tua sangat longgar dalam aturan dan memberikan kebebasan kepada anak-anak.
 - c. Pola Demokratis
Orang tua melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan, memberikan kebebasan dalam batas tertentu, dan memberikan alasan atas aturan yang diterapkan.

4. Nilai dan Tradisi:

a. Nilai Moral

Nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan hormat.

b. Tradisi Keluarga

Kebiasaan, ritual, dan perayaan yang diwariskan turun-temurun.

5. Struktur Fisik:

a. Tempat Tinggal

Rumah atau tempat tinggal yang menjadi pusat kehidupan keluarga.

b. Susunan Ruangan

Tata letak ruangan yang mencerminkan dinamika keluarga dan hubungan antar anggota.

Elemen-elemen ini saling terkait dan membentuk sistem yang kompleks dalam keluarga. Setiap keluarga memiliki struktur yang unik, dipengaruhi oleh budaya, latar belakang, dan pilihan pribadi (Canavan et al., 2000).

Struktur keluarga dapat menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat sekitarnya. Struktur keluarga mempunyai 4 elemen, yaitu (Potter & Perry, 2010):

1. Struktur peran keluarga

Struktur peran keluarga menggambarkan bagaimana peran dan tanggung jawab dibagi di antara anggota keluarga, baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Ini mencakup peran formal (seperti pekerjaan) dan peran informal (seperti peran dalam keluarga, misalnya sebagai pengasuh atau pencari nafkah). Pemahaman tentang struktur peran keluarga penting untuk memahami dinamika dan fungsi keluarga.

2. Nilai atau norma keluarga

Nilai dan norma keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, menunjukkan prinsip-prinsip dan keyakinan yang dianut keluarga dan memengaruhi perilaku kesehatan mereka. Ini mencakup pandangan tentang pentingnya kesehatan, kebiasaan sehat, dan akses terhadap layanan kesehatan.

3. Pola komunikasi keluarga

Pola komunikasi keluarga menjelaskan bagaimana komunikasi berlangsung di antara anggota keluarga, baik antara orang tua dan anak, antar saudara kandung, maupun antara keluarga inti dan keluarga besar. Ini mencakup gaya komunikasi, frekuensi komunikasi, dan efektivitas komunikasi dalam keluarga.

4. Struktur kekuatan keluarga

Struktur kekuatan keluarga menjelaskan bagaimana pengaruh dan kendali dibagi di antara anggota keluarga, dan bagaimana pengaruh tersebut digunakan untuk mendorong perilaku sehat dalam keluarga. Ini menunjukkan siapa yang memiliki suara terkuat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga.

C. Tipe Keluarga

Klasifikasi keluarga bervariasi tergantung pendekatan keilmuan orang yang mengelompokkan. Secara umum, terdapat dua tipe utama yaitu keluarga inti (ayah, ibu, dan anak kandung/adopsi) dan keluarga besar (keluarga inti plus kerabat dekat seperti kakek, nenek, paman, dan bibi). Masyarakat Indonesia umumnya menganut model keluarga besar atau tradisional.

Pembagian tipe keluarga berdasarkan struktur dan komposisinya dapat dijelaskan sebagai berikut (Pierce et al., 1996):

1. Keluarga Inti (Nuclear family/Conjugal family/Basic family): Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Ini adalah unit keluarga paling dasar dan sering disebut sebagai inti dari sebuah keluarga.
2. Keluarga Besar (Extended family/Consanguine family/Joint family): Keluarga besar tidak hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, tetapi juga termasuk kerabat dekat seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan keponakan. Mereka biasanya tinggal bersama atau saling berdekatan, menciptakan ikatan yang kuat dan tradisi keluarga yang kuat.
3. Keluarga Berantai (Serial family): Keluarga ini terdiri dari pasangan yang telah menikah lebih dari satu kali, membentuk keluarga inti baru dengan masing-masing pasangan. Ini sering terjadi dalam kasus perceraian atau kematian pasangan.
4. Keluarga Duda/Janda (Single family): Keluarga ini terbentuk ketika seseorang hidup sendiri karena perceraian atau kematian pasangan. Mereka bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak mereka dan menjalani kehidupan mandiri.
5. Keluarga Berkomposisi (Composite): Keluarga ini terjadi ketika poligami dipraktikkan, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dan semua istri hidup bersama dalam satu rumah tangga. Ini adalah bentuk keluarga yang jarang ditemukan di masyarakat modern, tetapi masih dipraktikkan di beberapa budaya.
6. Keluarga Kabitas (*Cohabitation*): Dua orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, tetapi membentuk unit

keluarga. Mereka berbagi kehidupan, tanggung jawab, dan pengasuhan anak (jika ada), meskipun tanpa status pernikahan resmi.

Penting untuk dicatat bahwa pembagian ini bukanlah mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, norma sosial, dan perspektif penelitian. Selain itu, bentuk-bentuk keluarga baru terus muncul seiring dengan perubahan sosial dan budaya.

Bentuk keluarga sangat beragam dan terus berkembang seiring perubahan sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa bentuk keluarga yang umum ditemukan (Potter & Perry, 2010):

1. Keluarga Inti: Merupakan bentuk keluarga yang paling sederhana, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka (jika ada). Bentuk ini sering disebut sebagai keluarga nuklir. Keluarga inti biasanya merupakan unit dasar dalam masyarakat dan sering kali dianggap sebagai bentuk keluarga yang ideal.
2. Keluarga Besar: Keluarga besar mencakup keluarga inti ditambah kerabat dekat seperti bibi, paman, kakek, nenek, dan sepupu. Mereka sering tinggal bersama dalam satu rumah tangga atau saling berdekatan, menciptakan ikatan yang kuat dan tradisi keluarga yang kuat.
3. Keluarga Orang Tua Tunggal: Keluarga ini terbentuk ketika salah satu orang tua meninggalkan keluarga inti karena berbagai alasan, seperti perceraian, kematian, atau pilihan pribadi. Orang tua tunggal bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak mereka dan memberikan dukungan emosional dan material.
4. Keluarga Campuran: Keluarga campuran terbentuk ketika orang tua membawa anak-anak dari hubungan sebelumnya ke dalam keluarga baru mereka. Ini bisa

terjadi melalui pernikahan kedua, adopsi, atau pengasuhan bersama. Keluarga campuran harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru dan membangun ikatan baru di antara anggota keluarga.

5. Pola Hubungan Alternatif: Bentuk keluarga ini semakin berkembang seiring perubahan sosial dan norma. Beberapa contohnya adalah:

- a. Rumah Tangga Multi-Generasi: Beberapa generasi tinggal bersama dalam satu rumah tangga, seperti kakek-nenek, orang tua, dan anak-anak. Ini dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota keluarga yang lebih tua dan anak-anak yang lebih muda.
- b. Keluarga 'Skip-Generation': Kakek-nenek mengasuh cucu mereka, tanpa kehadiran orang tua. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti orang tua yang masih muda, orang tua yang tidak mampu mengasuh anak, atau orang tua yang meninggal.
- c. Kelompok dengan Anak: Beberapa orang dewasa yang tidak terikat secara romantis memilih untuk tinggal bersama dan membesarkan anak-anak bersama. Ini bisa menjadi cara untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan dan biaya hidup.
- d. Non Keluarga: Individu dewasa yang tinggal sendiri, tanpa pasangan atau anak. Ini bisa menjadi pilihan hidup yang disengaja atau terjadi karena berbagai faktor, seperti perceraian, kesulitan menemukan pasangan, atau pilihan untuk hidup mandiri.
- e. Teman pada Tempat Tinggal yang Sama: Seiring dengan perubahan norma sosial, teman-teman memilih untuk tinggal bersama di satu tempat tinggal,

berbagi biaya hidup, dan memberikan dukungan sosial satu sama lain.

- f. Pasangan Homoseksual: Pasangan homoseksual yang hidup bersama, dengan atau tanpa anak, membentuk keluarga yang diakui secara hukum di beberapa negara.

Bentuk-bentuk keluarga ini menunjukkan bahwa definisi keluarga terus berkembang dan tidak lagi hanya terbatas pada model keluarga tradisional. Penting untuk menghargai keragaman bentuk keluarga dan memahami dinamika masing-masing bentuk untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan mendukung.

D. Fungsi Keluarga

Keluarga adalah pilar penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Secara umum, keluarga memiliki dua fungsi utama. yang pertama adalah Fungsi Internal (Psikologis-Sosial), yaitu fungsi ini berfokus pada kesejahteraan anggota keluarga itu sendiri. Keluarga menyediakan perlindungan dan dukungan emosional, psikologis, dan sosial bagi setiap anggotanya. Ini mencakup rasa aman, kasih sayang, penerimaan, dan kesempatan untuk berkembang secara individu. Keluarga yang sehat secara internal mampu memberikan rasa aman dan kepuasan emosional kepada setiap anggotanya, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. yang kedua adalah Fungsi Eksternal (Sosial-Budaya), yaitu fungsi ini berfokus pada peran keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Keluarga bertanggung jawab untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi selanjutnya. Hal ini mencakup pendidikan moral, etika, dan sosial. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang aturan

sosial, nilai-nilai budaya, dan cara berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Dengan demikian, keluarga berperan penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberhasilan fungsi eksternal ini memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma sosial tetap lestari dan diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu (Potter & Perry, 2010):

1. Reproduksi.

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan generasi dan menjaga populasi masyarakat agar tetap ada. Ini berarti keluarga memiliki peran penting dalam melahirkan anak dan memastikan kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Dengan adanya anak baru, populasi masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan.

2. Sosialisasi/edukasi.

Keluarga berperan sebagai jembatan untuk meneruskan nilai, keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda. Orang tua dan anggota keluarga lainnya mengajarkan anak-anak tentang cara hidup, aturan sosial, dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam keluarga dan masyarakat.

3. Penugasan peran sosial.

Keluarga memberikan identitas kepada anggotanya berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, agama, status sosial ekonomi, dan peran gender. Identitas ini membantu anggota keluarga memahami posisi mereka dalam masyarakat dan membentuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

4. Dukungan ekonomi.

Keluarga menyediakan tempat tinggal yang aman, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi anggota keluarganya.

5. Dukungan emosi/pemeliharaan

Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain. Dalam keluarga, anak-anak belajar tentang komunikasi, kerjasama, empati, dan bagaimana membangun hubungan sosial

Sedangkan menurut Oqbum dalam buku Sosiologi Pendidikan bahwa keluarga memiliki berbagai fungsi penting untuk kehidupan individu dan masyarakat. Secara umum, fungsi keluarga dapat dikelompokkan menjasdi fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan/penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga dan fungsi agama. Secara umum fungsi keluarga menurut Friedman (2010) mengidentifikasi fungsi dasar yang terdiri dari lima fungsi yaitu:

1. Fungsi Afektif dan Koping

Fungsi afektif keluarga adalah inti dari kekuatan dan kebahagiaan keluarga. Fungsi ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan psikososial setiap anggota, menciptakan iklim positif dan kebahagiaan bersama. Keberhasilan fungsi afektif terlihat dari rasa bahagia dan gembira yang dirasakan seluruh anggota keluarga, yang saling mendukung dan mempertahankan suasana positif. Untuk mencapai fungsi afektif yang optimal, keluarga perlu memenuhi beberapa komponen penting yaitu:

a. Saling Mengasuh, Cinta Kasih, Kehangatan, Penerimaan, dan Dukungan:

Ini adalah fondasi fungsi afektif. Anggota keluarga harus saling menunjukkan kasih sayang, kehangatan,

dan dukungan emosional. Mereka harus saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, serta memberikan dukungan dalam menghadapi kesulitan. Ini menciptakan rasa aman dan kepedulian di dalam keluarga.

b. Saling Menghargai:

Menghargai keberadaan dan hak setiap anggota keluarga sangat penting. Ini berarti mengakui perasaan, pendapat, dan kebutuhan setiap individu dalam keluarga, tanpa menghakimi atau merendahkan. Menghormati perbedaan pendapat dan memberikan ruang bagi ekspresi diri akan menciptakan iklim yang positif dan mendukung.

c. Ikatan dan Identifikasi:

Ikatan keluarga dimulai sejak awal pembentukan keluarga, dan terus berkembang seiring waktu. Proses identifikasi dan penyesuaian diri di berbagai aspek kehidupan membantu memperkuat ikatan ini. Anggota keluarga belajar untuk memahami dan menerima satu sama lain, membangun rasa kebersamaan dan identitas keluarga.

d. Mempertahankan Iklim Positif:

Ini adalah tujuan utama fungsi afektif. Keluarga harus secara aktif menciptakan dan mempertahankan suasana yang positif, penuh cinta, dan saling mendukung. Ini membutuhkan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk berkomunikasi secara terbuka, menyelesaikan konflik dengan damai, dan selalu berusaha untuk memahami perspektif satu sama lain.

2. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dan berperan dalam masyarakat, yang dimulai sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Keluarga berperan sangat penting dalam proses sosialisasi ini, menjadi tempat pertama bagi individu untuk belajar berinteraksi, memahami norma, budaya, dan perilaku yang sesuai. Hubungan dan interaksi antar anggota keluarga yang positif dan harmonis sangat penting untuk keberhasilan sosialisasi dan perkembangan individu, termasuk belajar disiplin dan norma-norma sosial.

3. Fungsi Reproduksi

Keluarga memiliki fungsi untuk melanjutkan generasi dan menambah jumlah penduduk. Program keluarga berencana membantu mengatur dan mengendalikan fungsi ini. Fungsi Ekonomi Fungsi ekonomi merupakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat berlindung.

4. Fungsi Perawatan Kesehatan

Keluarga berperan penting dalam menjaga kesehatan anggotanya, baik melalui pencegahan penyakit maupun perawatan saat sakit. Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan ini secara langsung memengaruhi kesehatan seluruh anggota keluarga. Keberhasilan keluarga dalam menjaga kesehatan dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas kesehatan keluarga.

E. Fungsi Dukungan Keluarga

Keluarga berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Peran ini mencakup beberapa fungsi utama: memberikan kasih sayang dan dukungan emosional, memenuhi kebutuhan ekonomi, mensosialisasikan dan mendidik anak, melindungi anak dari bahaya, dan menyediakan waktu untuk bersantai bersama. Proses pendidikan dan sosialisasi yang diterapkan orang tua kepada anak-anak sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian mereka. Setiap orang tua memiliki gaya pengasuhan yang berbeda, berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan mereka masing-masing, dalam upaya membimbing anak menuju kebaikan. Gaya pengasuhan ini, yang unik untuk setiap keluarga, akan membentuk karakter dan kepribadian anak secara unik pula (Sumiarsih, 2023).

Keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan, termasuk bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, sangat menentukan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Fungsi keluarga yang baik ditandai dengan gaya pengasuhan yang positif, sedikit konflik, dan hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Sebaliknya, fungsi keluarga yang buruk, ditandai dengan konflik yang sering terjadi dan hubungan yang tidak sehat, dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Terdapat beberapa fungsi keluarga, berikut adalah penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga adalah tempat pertama anak-anak belajar dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

2. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beragam, sehingga seluruh anggota keluarga dapat menghargai keberagaman budaya dalam satu kesatuan.

3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Keluarga menyediakan pondasi yang kuat untuk hubungan yang penuh kasih sayang antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya, lintas generasi. Hubungan-hubungan ini menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya cinta dan kasih sayang yang mendalam.

4. Fungsi Perlindungan

Keluarga adalah tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anggotanya. Di dalam keluarga, setiap anggota merasa terlindungi dan dicintai.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga memiliki peran penting dalam keberlangsungan umat manusia melalui perencanaan untuk memiliki anak. Keinginan untuk memiliki anak merupakan naluri alami manusia dan berperan dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga membimbing dan mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi kehidupan di masa depan dengan memberikan arahan dan pendidikan yang tepat. Peran keluarga dalam hal ini sangat penting untuk kesuksesan anak di masa depan.

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan keluarga itu sendiri. Ini berarti keluarga mampu mengatasi tantangan dan masalah yang

dihadapi secara mandiri dan tetap kokoh sebagai sebuah unit.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga membekali setiap anggotanya dengan kemampuan untuk beradaptasi dan hidup selaras dengan lingkungan yang selalu berubah. Ini memastikan keluarga dapat menghadapi perubahan dan tantangan yang ada dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lingkungan masyarakat. Keluarga memiliki beberapa fungsi dukungan, diantaranya yaitu (Sumiarsih, 2023)

1. Dukungan informasional

Keluarga berperan penting sebagai sumber informasi dan penyebar pengetahuan tentang dunia luar. Mereka memberikan nasihat, saran, dan informasi yang membantu anggota keluarga mengatasi masalah. Dukungan ini bersifat preventif, mencegah munculnya stres dengan memberikan panduan dan solusi yang tepat. Bentuk dukungan ini meliputi nasehat, usulan, saran, petunjuk, dan informasi yang relevan.

2. Dukungan penilaian

Keluarga bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator dalam memecahkan masalah, memberikan dukungan, penghargaan, dan perhatian yang membantu anggota keluarga menemukan jati diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Mereka memberikan umpan balik dan bimbingan untuk membantu anggota keluarga mengatasi tantangan dan mencapai potensi mereka.

3. Dukungan instrumental

Dukungan ini berupa bantuan langsung berupa fasilitas atau materi. Contohnya, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, meminjamkan uang, memberikan makanan, mainan, atau bentuk bantuan lainnya. Intinya, dukungan ini bersifat praktis dan langsung membantu memenuhi kebutuhan fisik atau material individu.

4. Dukungan emosional

Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anggota keluarganya untuk memulihkan diri dan mengelola emosi. Dukungan emosional ini ditunjukkan melalui kasih sayang, kepercayaan, perhatian, dan komunikasi yang saling mendengarkan. Keluarga menunjukkan empati, memberikan semangat, rasa hangat, cinta, dan bantuan emosional lainnya. Semua ini bertujuan agar individu merasa dihargai, dicintai, dan didukung secara emosional.

Sedangkan menurut (Pierce et al., 1996), dukungan keluarga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Dukungan Fisiologis

Dukungan fisiologis meliputi bantuan praktis dalam aktivitas sehari-hari, seperti membantu mandi, menyiapkan makanan bergizi, membantu buang air, menyediakan ruang pribadi yang nyaman, merawat saat sakit, membantu aktivitas fisik seperti senam, dan memastikan lingkungan yang aman. Intinya, dukungan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan kenyamanan individu.

2. Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis melibatkan pemberian perhatian, kasih sayang, dan rasa aman kepada anggota keluarga.

Dukungan ini juga membantu individu memahami dan menerima identitas dirinya, serta mendorong komunikasi yang baik melalui diskusi, percakapan yang berkualitas, dan penggunaan intonasi suara yang jelas. Intinya, dukungan ini berfokus pada kesehatan emosional dan mental individu.

3. Dukungan Sosial

Dukungan sosial mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan individu dalam lingkungan sosialnya. Ini termasuk saran untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan atau sosial (seperti pengajian atau arisan), memberikan kebebasan memilih layanan kesehatan, mendorong interaksi sosial, dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membangun rasa kebersamaan dan dukungan dari lingkungan sekitar.

F. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Terdapat hasil penelitian yang kuat yang menunjukkan perbedaan pengalaman perkembangan anak di keluarga besar dan kecil. Anak dalam keluarga kecil cenderung mendapat perhatian lebih dibandingkan anak dalam keluarga besar. Dukungan orang tua, terutama ibu, juga dipengaruhi usia; ibu muda seringkali kurang peka terhadap kebutuhan anak dan lebih mementingkan diri sendiri daripada ibu yang lebih tua (Bedaso et al., 2021)

Seberapa besar dukungan yang diberikan dalam sebuah keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah status Sosial Ekonomi. Keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik (kelas menengah) cenderung memiliki hubungan keluarga yang lebih setara dan demokratis, di mana setiap anggota merasa

dihargai dan didengarkan. Sebaliknya, keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang baik (kelas bawah) mungkin menunjukkan pola hubungan yang lebih otoriter, dengan hierarki kekuasaan yang lebih kaku. Secara umum, keluarga kelas menengah cenderung menunjukkan tingkat dukungan, kasih sayang, dan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga kelas bawah. Ini mungkin karena keluarga kelas menengah memiliki lebih banyak sumber daya (waktu, uang, dan akses ke layanan) untuk memberikan dukungan. Sedangkan yang kedua adalah Tingkat Pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam kemampuan keluarga untuk memberikan dukungan. Orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan, kesejahteraan, dan cara terbaik untuk mendukung anggota keluarga mereka, terutama saat menghadapi penyakit atau kesulitan. Mereka mungkin lebih mampu mengakses informasi dan sumber daya yang relevan, dan lebih mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dalam keluarga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan dukungan yang diberikan kepada anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan bantuan (Canavan et al., 2000)

Faktor lainnya adalah tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan kemungkinan semakin tinggi dukungan yang diberikan pada keluarga yang sakit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah sebagai berikut (Canavan et al., 2000):

1. Faktor Internal

- a. Tahap Perkembangan

Tahap perkembangan seseorang sangat mempengaruhi cara mereka memahami dan merespon

perubahan kesehatan, sehingga mempengaruhi jenis dukungan yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka memberikan dukungan kepada orang lain

b. Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan

Keyakinan seseorang akan mendapatkan dukungan dari orang lain dipengaruhi oleh faktor intelektual, meliputi pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Kemampuan kognitif, yang mencakup cara berpikir dan kemampuan memahami informasi, memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan ini. Seseorang dengan kemampuan kognitif yang baik lebih mampu memahami faktor-faktor risiko penyakit, dan menggunakan pengetahuan kesehatan untuk menjaga kesehatannya. Pengalaman masa lalu, baik pengalaman positif maupun negatif terkait dukungan, juga akan membentuk ekspektasi dan keyakinan seseorang tentang dukungan yang akan diterimanya di masa depan. Dengan kata lain, semakin banyak pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman positif seseorang, semakin besar kemungkinan ia percaya akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan, pendidikan yang rendah, dan pengalaman negatif dapat menyebabkan seseorang meragukan atau tidak percaya akan adanya dukungan.

c. Faktor Emosi

Cara seseorang memandang dan merespon dukungan, serta bagaimana mereka menghadapi penyakit, sangat dipengaruhi oleh faktor emosional. Reaksi emosional terhadap perubahan hidup dan stres berperan besar dalam bagaimana seseorang menafsirkan gejala fisik. Emosi dan kemampuan mengelola emosi sangat

mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dukungan, mencari dukungan, dan merespon penyakit. Kemampuan coping yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, terutama saat menghadapi tantangan kesehatan

d. Faktor Spiritual

Spiritualitas adalah cara seseorang menjalani hidup, meliputi nilai-nilai dan keyakinan yang dianut, hubungan dengan orang lain (keluarga, teman), serta kemampuan untuk menemukan makna dan harapan dalam hidup. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang pencarian makna hidup, tujuan hidup, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Spiritualitas yang kuat dapat memberikan rasa tujuan, kekuatan, dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk masalah kesehatan.

2. Faktor Eksternal

a. Praktik di Keluarga

Cara keluarga memberikan dukungan kesehatan sangat berpengaruh pada perilaku kesehatan anggota keluarganya. Perilaku sehat dalam keluarga cenderung ditiru oleh anggota keluarga lainnya. Contohnya, anak yang terbiasa diajak orang tuanya memeriksakan kesehatan secara rutin, besar kemungkinan akan melakukan hal yang sama ketika ia memiliki anak. Praktik kesehatan dalam keluarga menciptakan model perilaku yang diadopsi oleh anggota keluarga lainnya.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi seseorang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit dan mempengaruhi cara mereka menghadapi penyakit. Faktor-faktor seperti keharmonisan rumah tangga, gaya hidup, dan

lingkungan kerja (variabel psikososial) juga ikut berperan. Orang cenderung mencari dukungan dari lingkungan sosialnya, yang mempengaruhi bagaimana mereka memandang kesehatan dan mencari pertolongan. Biasanya, orang yang kondisi ekonominya lebih baik lebih cepat menyadari dan mencari pengobatan ketika merasakan gejala penyakit.

c. Latar Belakang Budaya

Budaya seseorang sangat memengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan mereka, termasuk cara mereka memberikan dan menerima dukungan, serta bagaimana mereka menjaga kesehatan. Cara seseorang memandang kesehatan, penyakit, dan pengobatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang budayanya.

Dukungan keluarga dan teman dekat sangat penting dalam menghadapi kecemasan dan rasa sakit. Kehadiran orang-orang terdekat dapat mengurangi rasa kesepian dan ketakutan, meskipun rasa sakitnya tetap ada. Dukungan ini sangat krusial, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan kehadiran orangtua saat mereka merasa sakit (Mardjan, 2016).

G. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan

Tugas kesehatan keluarga merupakan serangkaian tanggung jawab yang penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut (Sampeangin & Niman, 2022):

1. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, keluarga bertanggung jawab memberikan perawatan dan dukungan kepada anggota keluarga yang sedang sakit

2. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat, keluarga harus berupaya menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan kondusif untuk kesehatan semua anggota keluarga
3. Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat, keluarga harus menjalin hubungan yang baik dengan fasilitas kesehatan masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya.
4. Mengenal masalah kesehatan, kelompok keluarga harus mampu mengenali tanda dan gejala awal dari berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental.
5. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, keluarga harus dapat membuat keputusan yang bijak mengenai langkah-langkah kesehatan yang tepat untuk setiap anggota keluarga

Tugas keluarga mencakup berbagai aspek kehidupan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan setiap anggota, yang mencakup (Friedman, 2010):

1. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. Ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan akses perawatan kesehatan untuk memastikan kesehatan fisik setiap anggota keluarga
2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, Keluarga harus mengelola sumber daya yang dimilikinya secara bijak, termasuk keuangan, waktu, dan keterampilan anggota keluarga, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama.
3. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Pembagian tugas

yang adil dan sesuai kemampuan masing-masing anggota keluarga penting untuk efisiensi dan keseimbangan peran dalam keluarga. Ini bisa meliputi tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab finansial.

4. Sosialisasi antar anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan rasa saling hormat antar anggota keluarga sangat penting untuk membangun ikatan yang kuat dan memelihara hubungan yang harmonis.
5. Pengaturan jumlah anggota keluarga. Ini berkaitan dengan perencanaan keluarga, mempertimbangkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota dan merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kondisi keluarga.
6. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Menciptakan aturan dan norma dalam keluarga penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan disiplin, mengajarkan tanggung jawab, dan mencegah konflik.
7. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Keluarga berperan penting dalam mempersiapkan anggota keluarganya untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas, meliputi pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga. Keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat kepada setiap anggota untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menghadapi tantangan hidup

H. Manfaat Dukungan Keluarga

Menurut Brownell dan Schumaker ada tiga pengaruh atau manfaat dasar dari dukungan sosial diantaranya yaitu, pengaruh langsung, tidak langsung dan interaktif (Retnaningsih, 2021).

1. Pengaruh langsung, yaitu terciptanya hubungan interpersonal dan hubungan yang bersifat menolong dan hubungan tersebut dapat memfasilitasi terbentuknya perilaku yang lebih sehat.
2. Pengaruh tidak langsung, yaitu membantu individu menghadapi dan mengatasi stressor yang datang dengan mencoba membantu individu mempelajari cara pemecahan masalah dan mengontrol masalah-masalah kecil sebelum menjadi masalah besar.
3. Pengaruh interaktif, berupa dampak yang diinterpretasikan untuk mereda atau memperbaiki dampak-dampak yang merugikan dengan mempengaruhi kualitas dan kuantitas terhadap sumber-sumber coping.

Bab 3

Kecemasan

A. Definisi Kecemasan

Pada dasarnya Kecemasan adalah kondisi mental yang ditandai oleh rasa takut dan khawatir yang berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Kata "kecemasan" berasal dari bahasa Latin dan Jerman, menggambarkan dampak negatif dan reaksi fisik yang menyertainya. Menurut American Psychological Association (APA), kecemasan muncul sebagai respons terhadap stres, ditandai dengan ketegangan, pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, dan reaksi fisik seperti jantung berdebar kencang dan tekanan darah meningkat (Craske, 2003).

Kecemasan adalah rasa takut dan khawatir yang tak beralasan. Kecemasan ini sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang, terutama dalam mencapai kedewasaan. Kecemasan menjadi pendorong perilaku, baik yang normal maupun menyimpang. Perilaku menyimpang bisa jadi merupakan cara untuk mengatasi kecemasan. Oleh karena itu, kecemasan menjadi masalah utama dalam gangguan emosi dan perilaku (Craske, 2003).

Kecemasan adalah perasaan tegang dan gelisah yang muncul karena ketidakmampuan mengatasi masalah atau merasa tidak aman. Perasaan ini umumnya tidak nyaman dan disertai perubahan fisik dan mental. Kecemasan merupakan pengalaman pribadi yang menakutkan dan mengkhawatirkan akan bahaya yang mungkin terjadi, seringkali disertai gejala fisik karena peningkatan aktivitas sistem saraf otonom. Kecemasan juga diartikan sebagai ketegangan dan kekhawatiran akan hal buruk yang akan terjadi, namun penyebabnya seringkali tidak jelas, dan dapat bermanifestasi secara fisik maupun mental. Meskipun menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dan terus-menerus, kecemasan (pada tingkat ringan hingga sedang) tidak sampai mengganggu penilaian realitas atau kepribadian seseorang, meskipun perilaku dapat sedikit terganggu (Swarjana, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecemasan adalah rasa takut dan khawatir yang menetap dan tidak beralasan, berkaitan dengan ketidakpastian dan perasaan tidak berdaya. Rasa takut dan khawatir ini muncul tanpa penyebab yang jelas atau pasti.

B. Tanda dan Gejala Kecemasan

Terdapat beberapa tanda-tanda kecemasan. Tanda-tanda tersebut yaitu (Craske, 2003) :

1. Tanda-Tanda Fisik Kecemasan,

Gejala fisik kecemasan meliputi: gemetar, sensasi terikat di kepala, tegang di dada atau perut, berkeringat, pusing, mulut kering, kesulitan berbicara atau bernapas, jantung berdebar, suara bergetar, anggota badan dingin, lemas, sulit menelan, leher atau punggung kaku, sensasi tercekik,

tangan dingin dan lembap, sakit perut atau mual, menggigil, sering buang air kecil, wajah memerah, diare, dan mudah tersinggung.

2. Tanda-Tanda Behavioral Kecemasan

Tanda-tanda behavioral kecemasan diantaranya yaitu menghindari situasi yang memicu kecemasan, ketergantungan pada orang lain, dan perilaku yang menunjukkan guncangan emosi.

3. Tanda-Tanda Kognitif Kecemasan

Tanda-tanda kognitif kecemasan diantaranya: khawatir berlebihan, takut akan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, keyakinan akan datangnya bencana tanpa alasan yang jelas, terlalu fokus pada sensasi fisik, merasa terancam oleh hal-hal yang biasanya tidak diperhatikan, takut kehilangan kendali, takut tidak mampu mengatasi masalah, berpikir negatif dan berlebihan, khawatir akan hal-hal sepele, pikiran yang berulang dan mengganggu, keinginan untuk menghindari keramaian, pikiran yang kacau dan tidak terkendali, takut akan kematian, takut ditinggalkan, dan kesulitan berkonsentrasi.

Beberapa gejala kecemasan antara lain adalah:

1. Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang
2. Memandang masa depan dengan rasa was-was (khawatir)
3. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum (demam panggung)
4. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain
5. Tidak mudah mengalah
6. Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk, gelisah

7. Sering mengeluh ini dan itu (keluhan-keluhan somatik), khawatir berlebihan terhadap penyakit
8. Mudah tersinggung, membesar-besarkan masalah yang kecil (dramatisasi)
9. Dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan ragu
10. Bila mengemukakan sesuatu atau bertanya seringkali diulang-ulang
11. Apabila sedang emosi sering kali bertindak histeris

C. Faktor – Faktor Penyebab Kecemasan

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa - peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Terdapat beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan, diantaranya yaitu (Craske, 2003):

1. Lingkungan

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya.

2. Emosi

Emosi yang ditekan kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustrasi dalam jangka waktu yang sangat lama.

3. Sebab - Sebab Fisik Pikiran dan tubuh

sebab - sebab fisik pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu terkena suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan.

Kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata dan sewaktu-waktu terjadi pada diri individu serta adanya penolakan dari masyarakat menyebabkan kecemasan berada di lingkungan yang baru dihadapi.

Faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya (seperti keadaan emosi serta fokus ke permasalahannya)

Pada masa COVID 19, Kecemasan yang muncul akibat pandemi COVID-19 disebabkan oleh ketidakpastian dan hal-hal baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Munculnya virus ini menciptakan situasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, menimbulkan kecemasan karena perubahan mendadak dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sistem yang tiba-tiba memaksa orang untuk beradaptasi dengan cepat terhadap pola hidup baru, beralih dari kondisi normal ke situasi yang penuh kecemasan dan ketidakpastian. Ketidaktahuan tentang virus, cara penularannya, dan dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial memperburuk kecemasan tersebut. Kecemasan tersebut

merupakan akibat dari beberapa hal berikut ini (Hardiyati, 2020) :

1. Isolasi sosial, kurangnya interaksi, dan terbatasnya aktivitas fisik dapat memicu masalah kesehatan mental. Jika emosi negatif mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penderitaan, itu bisa menjadi tanda gangguan mental yang membutuhkan pertolongan profesional. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari secara normal, seperti bekerja, belajar, atau merawat diri sendiri, merupakan indikator penting yang perlu diperhatikan.
2. Kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti perubahan pola stres dan cara menghadapinya, gaya berpikir, dan kemampuan beradaptasi, serta faktor sosial, seperti dukungan dari orang-orang terdekat. Kemampuan seseorang untuk mengatasi stres, pola pikirnya, dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan, bersama dengan dukungan sosial yang diterimanya, berperan penting dalam menentukan kesejahteraan mentalnya. Sistem pendukung sosial yang kuat dapat menjadi penyangga yang penting dalam menghadapi tantangan hidup.

D. Dampak Kecemasan

Ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan yang tidak beralasan pada akhirnya menghadirkan kecemasan, dan kecemasan ini tentu akan berdampak pada perubahan perilaku seperti, menarik diri dari lingkungan, sulit fokus dalam beraktivitas, susah makan, mudah tersinggung, rendahnya pengendalian emosi amarah, sensitive, tidak logis, susah tidur.

Beberapa dampak dari kecemasan ke dalam beberapa simtom, antara lain (Craske, 2003) :

1. Simtom Suasana Hati. Seseorang yang mengalami kecemasan merasakan ancaman hukuman atau bencana yang datang dari sumber yang tak diketahui atau tak teridentifikasi. Rasa takut dan khawatir yang tak terjelaskan ini menimbulkan kegelisahan yang mendalam. Ketidakpastian mengenai sumber ancaman membuat individu tersebut merasa terancam dan tidak berdaya. Kondisi ini seringkali mengganggu tidur, menyebabkan insomnia, dan akibatnya, mengakibatkan mudah tersinggung dan marah. Kurangnya istirahat karena insomnia memperparah kecemasan dan meningkatkan sensitivitas terhadap rangsangan, sehingga memicu kemarahan lebih mudah. Siklus antara kecemasan, insomnia, dan mudah marah ini dapat memperburuk kondisi mental individu tersebut.
2. Simtom Kognitif Simtom Kognitif, yaitu kecemasan memicu kekhawatiran dan keprihatinan yang berlebihan terhadap kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Fokus individu tersebut teralihkan oleh kekhawatiran ini, sehingga mereka kesulitan berkonsentrasi pada tugas-tugas seperti bekerja atau belajar. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini kemudian memperkuat perasaan cemas, menciptakan siklus negatif di mana kecemasan mengganggu produktivitas, dan kurangnya produktivitas meningkatkan kecemasan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi yang tepat. Individu tersebut mungkin merasa terjebak dalam pikiran-pikiran negatif dan khawatir, sehingga sulit untuk fokus pada hal-hal positif dan produktif.

3. Simtom Motor, penderita kecemasan sering merasa gelisah dan gugup, menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang tidak bertujuan, seperti mengetuk-ngetuk kaki, dan bereaksi berlebihan terhadap suara-suara tiba-tiba. Gerakan-gerakan ini merupakan respons terhadap tingkat kewaspadaan yang tinggi dan upaya untuk melindungi diri dari ancaman yang dirasakan, meskipun ancaman tersebut mungkin tidak nyata atau berlebihan. Tubuh secara fisik merespon kecemasan dengan meningkatkan aktivitas motorik sebagai mekanisme koping, meskipun gerakan tersebut tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dalam mengatasi kecemasan itu sendiri.

E. Tingkatan Kecemasan

Semua orang pasti mengalami kecemasan pada derajat tertentu. Terdapat empat tingkatan kecemasan seseorang, tingkatan tersebut adalah (Craske, 2003):

1. Kecemasan Ringan

Kecemasan, dalam kadar tertentu, merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pendorong belajar, pertumbuhan, dan kreativitas. Pada tingkat ini, kecemasan ditandai dengan peningkatan kewaspadaan, perhatian yang lebih tajam terhadap lingkungan sekitar dan sensasi internal, kemampuan memecahkan masalah yang efektif, dan peningkatan kemampuan belajar. Secara fisik, individu mungkin merasa gelisah, sulit tidur, dan lebih sensitif terhadap suara, tetapi tanda-tanda vital dan ukuran pupil mata tetap normal. Ini berbeda dengan kecemasan yang bersifat patologis, yang ditandai dengan gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu kehidupan sehari-hari.

2. Kecemasan Sedang

Kecemasan pada tingkat sedang memungkinkan seseorang untuk fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan, menghasilkan perhatian yang selektif dan tindakan yang lebih terarah. Namun, respon fisiologisnya meliputi napas pendek, peningkatan denyut nadi dan tekanan darah, mulut kering, gelisah, dan sembelit. Dari segi kognitif, persepsi individu menyempit, mereka kesulitan memproses rangsangan eksternal, dan fokusnya hanya tertuju pada hal yang menjadi perhatian utama mereka. Meskipun fokus meningkat, gejala fisik dan penyempitan persepsi menunjukkan bahwa kecemasan pada tingkat ini tetap menimbulkan tekanan pada tubuh dan pikiran.

3. Kecemasan Berat

Kecemasan berat sangat mengganggu kemampuan individu untuk memproses informasi. Mereka cenderung terpaku pada detail-detail kecil dan tidak mampu memikirkan hal lain. Semua perilaku diarahkan untuk mengurangi rasa tegang yang luar biasa. Gejala-gejalanya meliputi persepsi yang sangat terbatas, fokus yang sempit pada detail, rentang perhatian yang sangat pendek, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, atau belajar secara efektif. Secara fisik, individu mungkin mengalami sakit kepala, pusing, mual, gemetar, insomnia, jantung berdebar, napas cepat, sering buang air kecil dan besar, dan diare. Secara emosional, mereka sangat ketakutan dan seluruh perhatian terpusat pada diri sendiri dan perasaan cemas mereka. Kecemasan pada tingkat ini sangat mengganggu dan membutuhkan bantuan profesional.

Kecemasan tingkat panik ditandai oleh rasa takut, teror, dan kehilangan kendali yang sangat intens. Individu dalam keadaan panik tidak mampu melakukan apa pun, bahkan jika diberi arahan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan aktivitas fisik yang tidak terkendali, kesulitan berkomunikasi, persepsi yang terdistorsi, dan hilangnya kemampuan berpikir rasional. Kecemasan panik sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan jika berlangsung lama dapat menyebabkan kelelahan ekstrem bahkan kematian. Salah satu gejala utamanya adalah ketidakmampuan untuk fokus pada apapun (Baer & Blais, 2010)

Beberapa skala penelitian dikembangkan untuk melihat seberapa besar tingkat kecemasan seseorang, salah satunya yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1956. HARS menggunakan serangkaian pertanyaan dengan jawaban yang harus diisi oleh pasien sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jawaban yang diberikan merupakan skala (angka) 0, 1, 2, 3, atau 4 yang menunjukkan tingkat gangguan dan setelah pasien menjawab sesuai apa yang dirasakannya, maka hasilnya dapat dihitung dengan menjumlahkan total skor yang didapat dari setiap soal (pernyataan).

HAM-A atau disebut juga HARS adalah salah satu skala peringkat pertama yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan pada orang dewasa, dan remaja, serta masih banyak digunakan saat ini baik dalam pengaturan klinis dan penelitian. Skala terdiri dari 14 item, masing-masing ditentukan oleh serangkaian gejala, dan mengukur kecemasan psikis (mental agitasi dan tekanan

psikologis) dan kecemasan somatik (keluhan fisik yang berhubungan dengan kecemasan).

Penilaian kecemasan berdasarkan HAM-A terdiri dari 14 item, meliputi (Baer & Blais, 2010):

1. Perasaan cemas (merasa khawatir, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, cepat marah, mudah tersinggung).
2. Ketegangan (merasa tegang, merasa lelah, merasa gelisah, merasa gemetar, mudah menangis, tidak mampu untuk rileks, mudah terkejut).
3. Ketakutan (takut terhadap gelap, takut terhadap orang asing, takut bila ditinggal sendiri, takut pada hewan, takut pada keramaian lalu lintas, takut pada kerumunan orang banyak).
4. Insomnia (kesulitan tidur, tidur tidak memuaskan, merasa lelah saat bangun, mimpi buruk, terbangun tengah malam).
5. Intelektual (sulit berkonsentrasi, sulit mengingat).
6. Perasaan depresi (kehilangan minat, kurangnya kesenangan dalam hobi, perasaan bersedih/depresi, sering terbangun dini hari saat tidur malam).
7. Gejala somatik (otot) (nyeri atau sakit otot, kedutan, otot terasa kaku, gigi gemertak, suara tidak stabil, tonus otot meningkat).
8. Gejala sensorik (telinga terasa berdenging, penglihatan kabur, muka memerah, perasaan lemah, sensasi ditusuk-tusuk).
9. Gejala kardiovaskuler (takikardi, palpitasi, nyeri dada, denyut nadi meningkat, perasaan lemas/lesu seperti mau pingsan, denyut jantung serasa berhenti sekejap).
10. Gejala pernapasan (nafas terasa sesak/dada terasa ditekan, perasaan tercekik, sering menarik napas dalam, napas pendek/tersengal-sengal).

11. Gejala gastrointestinal (kesulitan menelan, nyeri perut, perut terasa kembung, sensasi terbakar, perut terasa penuh, merasa mual, muntah, sulit BAB/sembelit, kehilangan berat badan).
12. Gejala genitourinari (frekuensi berkemih meningkat, tidak dapat menahan air seni, tidak datang bulan, darah haid lebih banyak dari biasanya).
13. Gejala otonom (mulut kering, muka kemerahan, muka pucat, sering berkeringat, merasa pusing, kepala terasa berat, merasa tegang, rambut terasa menegang).
14. Tingkah laku (gelisah, tidak tenang/mondar-mandir, tangan gemetar, alis berkerut, wajah tegang, pernafasan cepat, wajah pucat, sering menelan ludah, dll)

Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori sebagai berikut:

0 = tidak ada gejala sama sekali

1 = ringan/satu gejala yang ada

2 = sedang/separuh gejala yang ada

3 = berat/ lebih dari separuh gejala yang ada

4 = sangat berat semua gejala ada

Penentuan derajat atau tingkat kecemasan dengan cara menjumlahkan skor 1- 14 dengan hasil antara lain:

Skor kurang dari 14 = tidak ada kecemasan

Skor 14-20 = kecemasan ringan

Skor 21-27 = kecemasan sedang

Skor 28-41 = kecemasan berat

Skor 42-56 = kecemasan berat sekali (panik)

Bab 4

Kehamilan

A. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah proses yang menakjubkan di mana seorang wanita mengandung dan melahirkan seorang anak. Proses ini berlangsung selama sekitar 40 minggu, atau lebih dari sembilan bulan. Kehamilan dibagi menjadi tiga trimester: trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

B. Trimester dalam Kehamilan

Masa kehamilan dibagi ke dalam tiga trimester, yaitu:

1. Trimester pertama

Trimester pertama kehamilan adalah periode yang penting karena janin berkembang dengan cepat. Pada trimester ini, banyak ibu hamil mengalami gejala seperti morning sickness, kelelahan, dan perubahan suasana hati (Kemenkes RI, 2020).

a. Pembuahan

Proses kehamilan dimulai dengan pembuahan, di mana sel telur bertemu dengan sperma. Setelah pembuahan, materi genetik dari kedua orang tua bergabung untuk membentuk embrio.

b. Implantasi

Setelah pembuahan, embrio akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim. Di sini, embrio akan menempel pada dinding rahim, sebuah proses yang disebut implantasi.

c. Perkembangan Janin

Selama trimester pertama, organ-organ penting janin mulai berkembang. Pada minggu ke-8, janin sudah memiliki jantung yang berdetak

d. Risiko Keguguran

Risiko keguguran biasanya cukup tinggi selama trimester pertama. Oleh karena itu, ibu hamil harus menjaga kondisi dan vitalitas tubuh.

2. Trimester Kedua

Trimester kedua adalah periode yang lebih nyaman bagi sebagian besar ibu hamil. Gejala awal kehamilan seperti morning sickness biasanya akan menghilang.

a. Pertumbuhan Janin

Pada trimester kedua, janin terus tumbuh dan berkembang. Ia mulai bergerak, dan ibu hamil mungkin bisa merasakan gerakannya.

b. Perubahan Fisik

Ibu hamil akan mengalami perubahan fisik yang signifikan, seperti perut yang membesar dan payudara yang membesar.

3. Trimester Ketiga

Trimester ketiga adalah periode terakhir kehamilan, dan janin sudah hampir siap untuk lahir.

a. Persiapan kelahiran

Pada trimester ketiga, tubuh ibu hamil mulai mempersiapkan diri untuk kelahiran.

- b. Pertumbuhan otak
Pertumbuhan otak janin berlangsung terus dan cepat.
- c. Pematangan paru-paru
Paru-paru janin sudah matang dan siap bekerja sendiri

C. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan Trimester III

Trimester ketiga kehamilan, yang berlangsung dari minggu ke-28 hingga kelahiran, ditandai dengan perubahan fisik dan fisiologis yang signifikan pada tubuh ibu. Perubahan ini merupakan adaptasi alami tubuh untuk mempersiapkan persalinan dan kelahiran bayi. Pada kehamilan trimester ketiga, terdapat beberapa perubahan pada ibu hamil. Adapun perubahan tersebut antara lain adalah (Rankin, 2013):

1. Sistem pernafasan
 - a. Sesak napas
Perut yang membesar menekan diafragma, organ yang berperan dalam pernafasan. Hal ini menyebabkan sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik.
 - b. Peningkatan volume paru-paru
Tubuh meningkatkan volume paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat bagi ibu dan bayi.
 - c. Perubahan pola pernafasan
Ibu hamil mungkin mengalami pernafasan yang lebih cepat dan dangkal.
2. Sistem kardiovaskuler
 - a. Peningkatan volume darah
Volume darah ibu hamil meningkat sekitar 40-50% untuk menunjang kebutuhan bayi.
 - b. Peningkatan denyut jantung
Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang lebih banyak.

- c. Penurunan tekanan darah
Tekanan darah cenderung menurun pada trimester ketiga, terutama saat berbaring.
- 3. Sistem pencernaan
 - a. Sembelit
Perut yang membesar menekan usus, memperlambat proses pencernaan dan menyebabkan sembelit.
 - b. Mual dan muntah
Meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan trimester pertama, mual dan muntah masih bisa dialami pada trimester ketiga.
 - c. Asam lambung naik
Tekanan perut yang membesar dapat menyebabkan asam lambung naik, menimbulkan sensasi panas di dada.
- 4. Sistem urinaria
 - a. Sering buang air kecil
Bayi yang semakin besar menekan kandung kemih, menyebabkan ibu hamil sering buang air kecil.
 - b. Infeksi saluran kemih
Perubahan hormon dan aliran darah dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih
- 5. Sistem muskuloskeletal
 - a. Sakit punggung
Perut yang membesar dan perubahan postur tubuh dapat menyebabkan sakit punggung.
 - b. Kram kaki
Kram kaki sering terjadi karena perubahan aliran darah dan tekanan pada saraf.

- c. Relaksasi sendi
Hormon relaksin menyebabkan relaksasi sendi dan ligamen, membuat tubuh lebih fleksibel untuk persalinan
- 6. Perubahan lainnya
 - a. Kontraksi palsu (Braxton Hicks)
Kontraksi yang tidak teratur dan tidak nyeri yang membantu mempersiapkan tubuh untuk persalinan.
 - b. Bengkak pada kaki dan tangan
Penumpukan cairan dapat menyebabkan bengkak pada kaki dan tangan
Perubahan fisiologis yang terjadi pada trimester ketiga kehamilan merupakan proses alami yang membantu tubuh ibu mempersiapkan persalinan dan kelahiran bayi. Penting bagi ibu hamil untuk memahami perubahan ini dan mencari bantuan medis jika mengalami keluhan yang tidak biasa.

D. Perubahan Psikologis pada Kehamilan Trimester III

Pada ibu hamil trimester ketiga, terdapat perubahan fisik seperti (Rankin, 2013):

- 1. Perut membesar
Perut ibu hamil akan terus membesar seiring pertumbuhan bayi. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, seperti kesulitan bernapas, sembelit, dan sulit tidur.
- 2. Berat badan bertambah
Ibu hamil akan mengalami peningkatan berat badan secara signifikan pada trimester ketiga. Sebagian besar penambahan berat badan berasal dari bayi, plasenta, cairan ketuban, dan penambahan volume darah ibu.
- 3. Payudara membesar
Payudara ibu hamil akan terus membesar dan sensitif untuk mempersiapkan produksi ASI.

4. Kulit

Perubahan hormon dapat menyebabkan perubahan pada kulit, seperti munculnya stretch mark, pigmentasi kulit, dan jerawat.

5. Vagina

Vagina akan mengalami perubahan warna dan peningkatan aliran darah untuk mempersiapkan persalinan.

6. Kaki dan pergelangan kaki bengkak

Penumpukan cairan dapat menyebabkan kaki dan pergelangan kaki bengkak.

Perubahan fisik yang terjadi pada ibu di atas menyebabkan terjadinya perubahan psikologis ibu. Perubahan tersebut berupa (Rankin, 2013):

1. Khawatir dan cemas

Ibu hamil mungkin mengalami kecemasan menjelang persalinan, terutama jika ini adalah kehamilan pertama.

2. Perubahan suasana hati

Fluktuasi hormon dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang cepat dan tidak terduga.

3. Kesenangan

Ibu hamil juga mungkin merasakan kebahagiaan dan kegembiraan karena menantikan kelahiran bayi.

4. Ketegangan

Perubahan hormon dan tekanan fisik dapat menyebabkan ketegangan dan kelelahan.

Selain itu, adanya perubahan-perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pada ibu hamil seperti:

1. Tidur

Ibu hamil mungkin mengalami kesulitan tidur karena perut yang membesar, rasa tidak nyaman, dan kecemasan.

2. Aktivitas fisik

Ibu hamil mungkin merasa lelah dan sulit untuk melakukan aktivitas fisik yang berat.

3. Makanan

Ibu hamil mungkin mengalami perubahan selera makan dan mengalami keinginan untuk makan makanan tertentu.

Trimester ketiga kehamilan seringkali diiringi oleh beragam perubahan suasana hati dan emosi pada ibu hamil. Fluktuasi hormon yang signifikan dapat menyebabkan perasaan cemas, khawatir, atau bahkan depresi. Ketakutan akan persalinan, perubahan peran sebagai ibu, dan tanggung jawab mengasuh bayi baru lahir dapat memicu stres dan ketidakpastian. Di sisi lain, trimester ini juga dapat diwarnai dengan perasaan bahagia, antisipasi, dan kegembiraan menyambut kelahiran sang buah hati. Ibu hamil mungkin juga mengalami peningkatan sensitivitas emosional, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Penting untuk diingat bahwa setiap wanita mengalami perubahan psikologis yang berbeda-beda, dan mencari dukungan dari pasangan, keluarga, atau tenaga profesional kesehatan mental sangat dianjurkan untuk mengatasi tantangan emosional selama periode ini. Perubahan ini merupakan bagian normal dari kehamilan, namun jika perasaan negatif menjadi sangat mengganggu atau berkepanjangan, konsultasi dengan profesional sangat disarankan.

E. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Trimester III

Kebutuhan dasar ibu hamil dapat didasarkan pada usia kehamilannya. Hal ini disebabkan karena perubahan fisik dan psikologi pada masing-masing trimester berbeda-beda,

sehingga berpengaruh pada kebutuhannya. Adapun kebutuhan dasar pada ibu hamil trimester ketiga adalah (Rankin, 2013):

1. Kebutuhan oksigen

Bayi di trimester tiga tumbuh dengan cepat, membutuhkan lebih banyak oksigen untuk perkembangan organ dan sistem tubuhnya. Volume darah ibu hamil meningkat sekitar 40-50% untuk menunjang kebutuhan bayi. Ini berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang lebih banyak, dan tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk proses ini. Metabolisme ibu hamil meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan janin dan perubahan fisiologis tubuh. Organ-organ ibu juga membutuhkan lebih banyak oksigen untuk berfungsi dengan baik selama kehamilan. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut, tubuh meningkatkan volume paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Ibu hamil mungkin bernapas lebih cepat dan dangkal untuk mengambil lebih banyak oksigen serta aliran darah ke plasenta meningkat untuk memberikan oksigen dan nutrisi ke bayi.

2. Kebutuhan nutrisi

Ibu hamil trimester tiga membutuhkan sekitar 300 kalori lebih banyak dibandingkan kebutuhan kalori harian normal. Kalori ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan janin, produksi ASI, dan energi ibu untuk beraktivitas. Kebutuhan protein ibu hamil trimester tiga sekitar 70-100 gram per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitas ibu. Kebutuhan karbohidrat ibu hamil trimester tiga sekitar 360-420 gram per hari dimana karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk ibu

hamil. selain itu, juga diperlukan lemak untuk pertumbuhan otak dan saraf janin, serta untuk produksi hormon. Ibu memerlukan zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia sekitar 27 miligram per hari. Kalsium juga perlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta untuk menjaga kesehatan tulang ibu dengan jumlah sekitar 1000 miligram per hari. Ibu hamil memerlukan sekitar 600 mikrogram per hari asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Selain nutrisi di atas, ibu hamil trimester tiga juga membutuhkan vitamin dan mineral lainnya, seperti yodium, kolin, seng, vitamin A, vitamin B6 dan B12, vitamin C, dan vitamin D

3. Kebutuhan personal hygiene

Dengan meningkatnya metabolisme tubuh, ibu hamil trimester tiga perlu memberikan perhatian ekstra terhadap kebersihan diri untuk menjaga Kesehatan ibu dan bayi. Ibu hamil trimester tiga perlu mandi secara teratur, membersihkan areaewanitaan (menghindari douching atau pembersihan berlebihan), mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah menggunakan toilet dan sesudah memegang benda-benda yang kotor, menjaga kebersihan rambut, merawat kulit agar senantiasa lembab, mengganti pakaian dalam, serta memotong kuku untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

4. Kebutuhan istirahat dan tidur

Ibu hamil perlu memperhatikan kebutuhan istirahat dan tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan dan kantuk di siang hari, memengaruhi kemampuan mengingat dan berpikir, suasana hati, serta pengambilan keputusan pada ibu hamil. Pada janin, kurang tidur ibu

dapat menyebabkan masalah tumbuh kembang karena berkurangnya jumlah oksigen, nutrisi, dan hormon pertumbuhan yang dilepaskan saat ibu hamil tertidur. Terdapat beberapa tips dalam meningkatkan kualitas tidur diantaranya adalah:

- a. Tidur miring ke kiri, posisi tidur ini dianggap sebagai posisi terbaik selama kehamilan karena dapat memperlancar aliran darah ke jantung, ginjal, dan rahim, sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke janin juga meningkat
 - b. Praktik *Sleep Hygiene* Membangun kebiasaan tidur yang sehat dan efektif dengan cara tidur dan bangun di waktu yang sama, melakukan rutinitas pengantar tidur, meredupkan lampu kamar, membatasi tidur siang, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman
 - c. Menghindari makanan pedas dan kafein, makanan pedas dapat memicu *heartburn*, sedangkan kafein dapat membuat ibu hamil susah tidur
 - d. Relaksasi, yaitu menjelang tidur melakukan relaksasi agar pikiran dan otot tubuh menjadi rileks.
5. Kebutuhan exercise

Memasuki trimester ketiga kehamilan, banyak ibu hamil yang merasa khawatir untuk melakukan aktivitas fisik, termasuk olahraga. Padahal, olahraga yang tepat di trimester ketiga memiliki banyak manfaat bagi ibu dan janin. Adapun manfaat olahraga pada trimester tiga antara lain adalah memperlancar proses persalinan, meningkatkan daya tahan tubuh, meringankan pegal dan nyeri serta menjaga kesehatan mental. Olahraga di trimester ketiga kehamilan dapat memberikan banyak manfaat bagi ibu dan janin. Dengan melakukan olahraga

yang tepat, ibu hamil dapat menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri untuk persalinan yang lancar.

6. Kebutuhan pakaian

Memasuki trimester ketiga, kebutuhan pakaian ibu hamil akan berubah. Pastikan untuk memilih pakaian yang nyaman, longgar, dan mudah dilepas pasang untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan ibu dan janin. Jangan lupa untuk mempersiapkan pakaian untuk persalinan dan aksesoris yang diperlukan

7. Kebutuhan seksual

Keinginan dan pengalaman seksual selama kehamilan, khususnya di trimester ketiga, sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor fisik dan emosional. Perubahan hormonal dan fisik yang signifikan dapat memengaruhi gairah seksual, sementara rasa cemas menjelang persalinan juga dapat berperan. Meskipun beberapa ibu hamil mengalami penurunan libido, banyak juga yang tetap merasakan hasrat seksual yang tinggi atau bahkan meningkat. Penting untuk diingat bahwa setiap kehamilan dan setiap wanita itu unik, sehingga respons terhadap seksualitas selama trimester ketiga sangat individual. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan sangat krusial untuk memahami dan menghargai perubahan-perubahan ini, serta menemukan cara untuk tetap menikmati keintiman dan keintiman seksual dengan aman dan nyaman. Posisi seksual yang nyaman perlu disesuaikan dengan kondisi fisik ibu hamil, dan selalu penting untuk memprioritaskan kenyamanan dan kesejahteraan ibu.

8. Persiapan persalinan

Menjelang akhir kehamilan, memasuki trimester ketiga, persiapan persalinan menjadi sangat penting. Ini

mencakup berbagai aspek, mulai dari mempersiapkan perlengkapan bayi dan perlengkapan rumah sakit, hingga merencanakan dukungan selama persalinan dan masa nifas. Ibu hamil perlu memastikan akses mudah ke layanan kesehatan, termasuk memilih dokter atau bidan, dan memahami rencana persalinan yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional, misalnya dengan mengikuti kelas persiapan persalinan atau berdiskusi dengan pasangan dan keluarga untuk membangun dukungan yang kuat. Memastikan lingkungan rumah yang nyaman dan aman untuk menyambut bayi baru lahir juga merupakan bagian penting dari persiapan ini. Intinya, persiapan persalinan di trimester ketiga adalah proses holistik yang melibatkan aspek fisik, logistik, dan psikososial untuk menyambut kelahiran bayi dengan tenang dan percaya diri.

Bab 5

Dampak Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil

Hubungan kekeluargaan yang baik antara keluarga dengan ibu hamil sangat diperlukan, khususnya dukungan keluarga pada ibu hamil. Dengan adanya dukungan ini dapat membantu ibu dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang ibu hadapi khususnya ibu yang sedang hamil dan menjelang proses persalinan. Dukungan keluarga juga berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang dimana peran keluarga adalah sesuatu yang diharapkan secara normatif dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Kecemasan dapat terjadi jika ada konflik dalam keluarga (Wulandari et al., 2022).

Gangguan kecemasan adalah sekelompok kondisi yang memberi gambaran penting tentang kecemasan yang berlebihan, disertai respons perilaku, emosional, dan fisiologis. Individu yang mengalami gangguan kecemasan dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupan, melalui tindakan berulang –

ulang tanpa dapat dikendalikan, mengalami kembali peristiwa yang traumatic atau rasa khawatir yang berlebihan. pada beberapa kejadian, banyak orang yang memperlihatkan salah satu dari perilaku yang tidak lazim tersebut sebagai respon normal terhadap kecemasan. Perbedaan antara respon kecemasan yang tidak lazim ini dengan gangguan kecemasan adalah bahwa respons kecemasan cukup berat sehingga bisa mengganggu kerja individu, kehidupan sosial dan lingkungan sosial. Jika ini terjadi pada ibu hamil khususnya ibu hamil menjelang proses persalinan dapat berpengaruh pada ibu serta janin yang dikandungnya. Keberadaan dukungan keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Disamping itu, pengaruh positif dari dukungan sosial keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress (Sari et al., 2019)

Dukungan keluarga memberikan berbagai bentuk dukungan (moral, material, fisik, psikologis, informasi) yang penting bagi ibu hamil. Kecemasan yang berlebihan pada ibu hamil dapat berdampak negatif bagi ibu dan bayi. Dukungan keluarga yang kuat terbukti mengurangi kecemasan dan meningkatkan adaptasi ibu hamil terhadap *stressor* (Gondwe & Holditch-Davis, 2015)

Wanita hamil dengan komplikasi kehamilan, wanita yang dirawat inap selama kehamilan, dan wanita dengan riwayat dismenore memiliki skor kecemasan kehamilan yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Wanita yang menghadiri kelas persiapan persalinan atau memiliki pengetahuan tentang analgesia selama persalinan memiliki skor kecemasan kehamilan yang lebih rendah daripada rekan-rekannya. Hasil menunjukkan bahwa skor kecemasan wanita yang

menginginkan operasi caesar lebih tinggi daripada wanita yang cenderung melahirkan secara normal (Madhavanprabhakaran et al., 2015)

Wanita yang menggambarkan kehamilan mereka buruk atau sangat buruk, wanita yang merasa tidak sehat, wanita yang memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan, mereka yang menerima dukungan emosional yang rendah dari pasangan mereka, dan wanita yang tidak puas dengan hubungan pernikahan memperoleh skor kecemasan kehamilan yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Berdasarkan hasil analisis, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat dismenore, riwayat rawat inap selama kehamilan, kurangnya pengetahuan tentang analgesia selama persalinan, persepsi kesehatan yang buruk, dan menerima dukungan emosional yang buruk dari pasangan merupakan faktor risiko independen kecemasan kehamilan (Peter et al., 2017)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Bali tentang hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan menunjukkan hasil mayoritas responden mendapatkan dukungan keluarga yang sedang yaitu (70,2%) dan mayoritas responden tidak cemas (87,1%). Responden yang mendapatkan dukungan yang tinggi dari keluarga mayoritas tidak mengalami kecemasan sedangkan responden yang mendapatkan dukungan yang rendah dari keluarga mengalami kecemasan yang sedang. Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan responden dalam menghadapi persalinan pada pandemi Covid 19. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan keluarga kepada ibu hamil dalam menghadapi persalinan maka kecemasan yang dialami oleh ibu semakin rendah (Wulandari et al., 2022)

Berdasarkan studi yang dilakukan di Tiongkok tentang kecemasan pada ibu hamil dengan dukungan keluarga dan dukungan sosial menunjukkan hasil bahwa terdapat 41,4% wanita hamil Tiongkok yang menunjukkan kecemasan. Jumlah ibu yang mengalami kecemasan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Belanda (11%), Tanzania (25%), Iran (21%) dan Qatar (26,5%) dan lebih rendah jika dibandingkan dengan yang dilaporkan di India (55,7%). Hasil analisis menunjukkan terdapat korelasi antara dukungan sosial yang dirasakan dan fungsi keluarga berasosiasi negatif dengan kecemasan ibu hamil ($r = -0.47, P < 0.01$; $r = -0.43, P < 0.01$; $r = -0.37, P < 0.01$, respectively). Semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin rendah kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil. Fungsi keluarga dan dukungan sosial yang dirasakan dapat mengurangi kejadian kecemasan, sehingga disarankan penyedia layanan kesehatan harus memperhatikan kecemasan yang terjadi pada ibu hamil serta menerapkan dan mendorong langkah-langkah yang dapat mencegah/menurunkan kecemasan ibu hamil (Huang et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi non-farmakologis yaitu pemberian dukungan keluarga paling efektif dilakukan selama kehamilan atau masa nifas, bukan selama persalinan. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh perawat dan juga bidan untuk mengurangi kecemasan selama kehamilan, persalinan dan nifas juga dapat mengurangi terjadinya kecemasan pada ibu (Domínguez-solís et al., 2021).

Suatu studi di Iran yang melibatkan 358 orang sampel menunjukkan hasil sebanyak 1,3% wanita memiliki dukungan keluarga yang buruk, 27,9% memiliki dukungan keluarga yang sedang, dan 69% memiliki dukungan keluarga yang baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga ibu dengan paritas. Ibu dengan paritas yang tinggi mempunyai

dukungan keluarga yang lebih rendah. Selain itu, studi juga menunjukkan rendahnya dukungan keluarga pada kehamilan yang tidak diinginkan (Abdollahpour et al., 2015).

Bab 6

Penutup

Dukungan keluarga sangat penting bagi ibu hamil di trimester ketiga untuk mengurangi kecemasan yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, praktis, dan informasi yang sangat dibutuhkan ibu hamil untuk menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan. Dukungan ini bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan vital yang berdampak positif pada perjalanan kehamilan yang sehat dan bahagia. Dengan saling mendukung, memahami, dan berbagi beban, keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu hamil, sehingga ia dapat fokus pada pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dikandungnya.

Melalui buku ini, kita dapat menarik benang merah bahwa seluruh pihak keluarga perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil khususnya ibu hamil trimester III agar nantinya tidak terjadi kecemasan yang dapat menyebabkan dampak negative, baik pada ibu maupun bayinya.

Adapun beberapa pihak yang dapat terlibat dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil trimester III dalam mencegah terjadinya kecemasan adalah:

1. Tenaga Kesehatan agar lebih sering memberikan informasi tentang pentingnya dukungan keluarga dalam mendukung ibu hamil dalam menghadapi persalinan

2. Keluarga dapat memberikan dukungan secara kompleks baik yang menyangkut dukungan informasi, dukungan penilaian, dukungan emosional maupun dukungan tambahan kepada ibu hamil sebagai salah satu upaya meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan

Untuk itu, mari kita semua berperan aktif dalam memberikan dukungan tersebut, karena kesehatan ibu dan bayi adalah tanggung jawab bersama.

Daftar Pustaka

- Abdollahpour, S., Ramezani, S., & Khosravi, A. (2015). Perceived social support among family in pregnant women. *International Journal of Pediatrics*, 3(5), 879–888. <https://doi.org/10.22038/ijp.2015.4703>
- Alves, A. C., Cecatti, J. G., & Souza, R. T. (2021). *Resilience and Stress during Pregnancy: A Comprehensive Multidimensional Approach in Maternal and Perinatal Health*. 2021.
- Baer, L., & Blais, M. A. (Eds.). (2010). *Handbook of Clinical Rating Scales and Assessment in psychiatry and Mental Health*. humana Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-59745-387-5>
- Basharpour, S., Heydarirad, H., Daryadel, S. J., Heydari, F., Ghamari Givi, H., & Kishore, J. (2017). The Role of Perceived Stress and Social Support among Predicting Anxiety in Pregnant Women. *Journal of Holistic Nursing and Midwifery*, 27(2), 9–16. <https://doi.org/10.18869/acadpub.hnmj.27.2.9>
- Bedaso, A., Adams, J., Peng, W., & Sibbritt, D. (2021). The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: a systematic review and meta - analysis. *Reproductive Health*, 1–23. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01209-5>
- Berg, A. I. V. D. Z. Den, Boere-boonekamp, M. M., Catharina, G., Groothuis-oudshoorn, M., & Reijneveld, S. A. (2021). Postpartum depression and anxiety : a community-based study on risk factors before , during and after pregnancy. *Journal of Affective Disorders*, 286(January), 158–165. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.062>
- Canavan, J., Dolan, P., & Pinkerton, J. (2000). *Family Support: Direction From Diversity* (First). Jessica Kingsley Publisher.

- Craske, M. G. (2003). *Origins of Phobias and Enxiety Disorders: Why More Women Than Men* (first). Elsevier Ltd.
- Domínguez-solís, E., Lima-serrano, M., & Lima-rodríguez, J. S. (2021). *Non-pharmacological interventions to reduce anxiety in pregnancy , labour and postpartum: A systematic review. 102*(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103126>
- Friedman, M. M. (2010). *Keperawatan Keluarga*. EGC.
- Gondwe, K. W., & Holditch-Davis, D. (2015). Posttraumatic stress symptoms in mothers of preterm infants. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 3, 8–17. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2015.05.002>
- Hardiyati. (2020). *Kecemasan Pada Saat Pandemi Covid 19* (Jariah Publishing Intermedia (Ed.)).
- Huang, J., Xu, L., Xu, Z., Luo, Y., Liao, B., Li, Y., & Shi, Y. (2022). The relationship among pregnancy-related anxiety, perceived social support, family function and resilience in Chinese pregnant women: a structural equation modeling analysis. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02145-7>
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak. In *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Madhavanprabhakaran, G. K., D'Souza, M. S., & Nairy, K. S. (2015). Prevalence of pregnancy anxiety and associated factors. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 3, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2015.06.002>
- Mardjan. (2016). *Pengaruh Kecemasan pada Kehamilan Primipara Remaja* (Abrori (Ed.)). Abrori Institute. <https://doi.org/6023960758>

- Peter, P. J., de Mola, C. L., de Matos, M. B., Coelho, F. M., Pinheiro, K. A., da Silva, R. A., Castelli, R. D., Pinheiro, R. T., & Quevedo, L. A. (2017). Association between perceived social support and anxiety in pregnant adolescents. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 39(1), 21–27. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2015-1806>
- Pierce, G. R., Sarason, B. R., & Sarason, I. G. (1996). *Handbook of Social Support and the Family*. Plenum Press.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2010). *Fundamental Keperawatan* (7th ed.). Elsevier Inc.
- Rafiei, N., Amini Rarani, M., Eizadi, F., Rafiey, H., & Seyedghasemi, N. S. (2019). Social support and its role in the prevention of depression and anxiety during pregnancy in Turkmen women. *International Journal of Biomedicine and Public Health*, 2(4), 75–80. <https://doi.org/10.22631/ijbmph.2020.167433.1098>
- Rankin, J. (2013). *Myles Midwifery: Anatomy and Physiology Workbook*. Elsevier Inc.
- Retnaningsih, D. (2021). *Keperawatan Keluarga*. Deepublishh.
- Sampeangin, H., & Niman, S. (2022). *Keperawatan Keluarga dengan Trend Masalah Psikososial Keluarga*. CV Trans Info Media.
- Sari, D. K., Dewi, R., & Daulay, W. (2019). Association between family support, coping strategies and anxiety in cancer patients undergoing chemotherapy at General Hospital in Medan, North Sumatera, Indonesia. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 20(10), 3015–3019. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2019.20.10.3015>
- Schetter, C. D., Tanner, L., & Angeles, L. (2015). *Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice*. 25(2), 141–148. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503680>
- Setiono, K. (2011). *Psikologi Keluarga* (Pertama). PT. Alumni.
- Sumiarsih, G. (2023). *Dukungan Keluarga dan Aktivitas Fisik Menuju*

Succesfull Aging (D. Larasati (Ed.); Pertama). CV. Mitra Edukasi Negeri.

- Swarjana, I. K. (2022). *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid 19, Akses Layanan Kesehatan- Lengkap dengan Konsep Teori, Cara mengukur Variabel dan Contoh Kuesioner*. Penerbit Andi.
- Wang, Y., Gu, J., Zhang, F., & Xu, X. (2024). *The multiple mediation model of social support and postpartum anxiety symptomatology: the role of resilience, postpartum stress, and sleep problems*.
- Wulandari, I. A., Wayan, N., & Parwati, M. (2022). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Persalinan Pada Pandemi COVID 19 Di Provinsi Bali*. 7(1), 20–25.
- Yu, M., Qiu, T., Liu, C., Cui, Q., & Wu, H. (2020). The mediating role of perceived social support between anxiety symptoms and life satisfaction in pregnant women: a cross-sectional study. *Health and Quality of Life Outcomes*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01479-w>

Glosarium

A

Angka Kematian Ibu: banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi: banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

B

BBLR: kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram atau 2,5 kg

D

Depresi: gangguan jiwa yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti sedih, muram dan tertekan

K

Kecemasan: rasa takut dan khawatir yang menetap dan tidak beralasan, berkaitan dengan ketidakpastian dan perasaan tidak berdaya. Rasa takut dan khawatir ini muncul tanpa penyebab yang jelas atau pasti

Kehamilan: proses selama sembilan bulan atau lebih dimana seseorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam

Kehamilan Trimester III: kehamilan pada minggu ke-28 sampai minggu ke-40

Kelahiran Premature: persalinan yang terjadi setelah 20 minggu dan sebelum 37 minggu kehamilan

Keluarga: kelompok individu yang terikat oleh pernikahan, adopsi, atau kelahiran, yang bersama-sama menciptakan dan menjaga nilai-nilai bersama, serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya

O

Operasi Caesar: prosedur pembedahan yang melibatkan sayatan dinding perut dan Rahim untuk melahirkan bayi

P

Persalinan: proses dimana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam

S

Stress: ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut

Profil Penulis



Bdn. Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb,

Penulis adalah seorang bidan yang menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan tahun 2002 di Akademi Kebidanan Jember yang saat ini telah berubah bentuk dan tergabung dalam Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada tahun 2004, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2009, penulis menempuh pendidikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2011 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat.

Penulis sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) sejak tahun 2003. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan. Hasil karya ilmiah telah terpublikasi di jurnal nasional terindeks SINTA, serta beberapa hasil cipta yang mendapatkan HaKI. Selain menjadi dosen yang melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, penulis juga aktif di organisasi IBI yaitu sebagai pengurus harian Pengrus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali, Praktik Mandiri Bidan (PMB) sejak tahun 2007, Fasilitator Pelatihan KB bagi Tenaga Dokter dan Bidan Provinsi Bali, evaluator pembukaan prodi baru serta menjadi asesor LAMPTKes. Harapan penulis semoga kedepannya dapat mencetak karya yang lebih sempurna sehingga kritik dan saran diharapkan guna peningkatan dan kualitas pada penulisan selanjutnya.

Email Penulis: ayuwulandari28@gmail.com

Profil Penulis



Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T., M.Keb, seorang bidan kelahiran Denpasar, 9 Mei 1982 yang telah menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan tahun 2003 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Tahun 2004, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. Tahun 2015, penulis menyelesaikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Penulis juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan non formal seperti Pijat Bayi, Mom and Baby SPA, Hypnobirthing dan Yoga Prenatal.

Penulis aktif sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) sejak tahun 2005. Penulis menunjukkan ketertarikan di bidang Nifas dan menyusui sejak pertama kali bergabung menjadi dosen di ITEKES Bali, hingga saat ini penulis masih dipercaya menjadi Koordinator Bidang Nifas Program Studi Kebidanan. Berbagai penelitian di bidang nifas dan menyusui telah dipublikasikan. Penulis juga telah membuat book chapter terkait nifas dan menyusui, buku referensi, Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, modul praktikum nifas, buku panduan pijat oksitosin pada ibu menyusui. Keseriusan penulis dalam melaksanakan kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi telah mengantarkan penulis menjadi dosen terbaik kedua LLDIKTI wilayah VIII tahun 2019.

Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum.

Email Penulis: manikparwati82@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap pencegahan terjadinya kecemasan pada ibu hamil khususnya ibu hamil trimester III. Trimester ketiga kehamilan adalah periode yang penuh tantangan bagi ibu hamil, terutama dalam menghadapi persalinan. Kecemasan yang berlebihan pada masa ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi kecemasan ibu hamil trimester III.

Kecemasan menyebabkan terjadinya kelahiran premature, BBLR, berpotensi menyebabkan masalah pada perkembangan otak janin dan kesehatan anak setelah lahir. Untuk itu, ibu hamil diharapkan dapat melewati masa kehamilan dengan lebih tenang dan bahagia, serta mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu dengan penuh percaya diri. Hal ini tentunya dapat tercipta dengan adanya dukungan dari orang sekitar ibu hamil trimester III, khususnya dari keluarga. Peran keluarga sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menenangkan bagi ibu hamil, sehingga dapat mencegah munculnya kecemasan berlebihan.

Buku ini membahas tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap pencegahan terjadinya kecemasan pada ibu hamil khususnya ibu hamil trimester III. Trimester ketiga kehamilan adalah periode yang penuh tantangan bagi ibu hamil, terutama dalam menghadapi persalinan. Kecemasan yang berlebihan pada masa ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi kecemasan ibu hamil trimester III.

Kecemasan menyebabkan terjadinya kelahiran premature, BBLR, berpotensi menyebabkan masalah pada perkembangan otak janin dan kesehatan anak setelah lahir. Untuk itu, ibu hamil diharapkan dapat melewati masa kehamilan dengan lebih tenang dan bahagia, serta mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu dengan penuh percaya diri. Hal ini tentunya dapat tercipta dengan adanya dukungan dari orang sekitar ibu hamil trimester III, khususnya dari keluarga. Peran keluarga sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menenangkan bagi ibu hamil, sehingga dapat mencegah munculnya kecemasan berlebihan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-03-0



9

786347

139030

